

SRH Hochschule Heidelberg
Fakultät für Angewandte Psychologie
Staatlich anerkannte Hochschule

Master-Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science Psychologie

Thema:
**Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden unter
Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes**

Eingereicht von: Teresa Seidl Fernández
Matrikelnummer: 11013160
Gruppennummer: 63742201

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Andrés Steffanowski
Betreuende Dozentin: Fr. Farrenkopf

Heidelberg, den 14. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	4
1.1	Konstrukte	4
1.1.1	Religion und Religiosität	4
1.1.1.1	Auswirkung auf die Gesundheit	7
1.1.2	Kultur	9
1.1.2.1	Operationalisierung von Kultur	10
1.1.2.2	Auswirkung auf die Gesundheit	12
1.1.3	Wohlbefinden	13
1.1.3.1	Biopsychosoziales Modell	15
1.2	Aktueller Forschungsstand	17
1.2.1	Hypothese 1	17
1.2.2	Hypothese 2	18
1.2.3	Hypothese 3	20
2	Methoden	22
2.1	Stichprobenbeschreibung	22
2.2	Untersuchungsdesign	22
2.3	Operationalisierung der Konstrukte	23
2.4	Untersuchungsdurchführung	25
2.5	Auswertungsmethode	26
	Literaturverzeichnis	27

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Theorie

In diesem Kapitel werden zunächst die verwendeten Konstrukte Religion und Religiosität, psychisches Wohlbefinden und abschließend die Kultur erläutert. Anschließend folgt eine theoretische Herleitung der einzelnen Hypothesen.

1.1 Konstrukte

Im Anschluss erfolgt in den Unterkapiteln eine Einführung in die einzelnen Konstrukte. Beginnend werden in Kapitel 1.1.1 Religion und Religiosität präsentiert und wie sie im Rahmen dieser Studie untersucht werden. In Kapitel 1.1.2 wird erklärt welche Rolle die Kultur spielt und wie sie mit den anderen beiden Konstrukten interagiert. Im abschließenden Kapitel 1.1.3 wird erläutert was psychisches Wohlbefinden ist. Dieses Unterkapitel geht anschließend auf Methoden für dessen Aufrechterhaltung ein.

1.1.1 Religion und Religiosität

Die Religion verleiht vielen Menschen ihrem Leben Sinn und Zweck. Selbst in stark säkularisierten Ländern wie Westeuropa, wie vom Pew Research Center (2022) berichtet, gaben im Median 39% an, dass die Religion ihnen dieses Gefühl vermittelt. Zudem bietet sie Trost in Zeiten der Trauer und moralische Orientierung bei schwierigen Entscheidungen. Viele Menschen sehen das Hauptziel von organisierter Religion darin, Menschen zu vereinen und zusammenzubringen (Pew Research Center, 2022).

Unter organisierter Religion fallen Religionsgemeinschaften, die ein einheitliches und förmlich festgelegtes Glaubenssystem und Rituale besitzen. Diese Systeme und Rituale sind oftmals durch eine offizielle Doktrin, eine hierarchische Führungskraft und einer Kodifizierung der richtigen und falschen Verhaltensweisen festgelegt. Diese unterscheiden sich von nichtorganisierter Religion. Die meisten Personen nichtorganisierter Religion glauben an Gott oder eine höhere Macht, sie haben aber keine Beziehung zu einer organisierten Religionen und umfassen moderne Spiritualitätsformen (Köhrsen, 2024). Davon zu unterscheiden ist die organisierte und nichtorganisierte Religiosität. Religion bezieht sich auf die äußerliche Beschreibungsebene, wobei Religiosität das innere Erleben beschreibt (Allolio-Näcke & Demmrich, 2022). Unter organisierter Religiosität werden solche Praktiken verstanden, die in einem sozialen Umfeld gelebt werden. Beispiel dafür sind der Besuch von Gottesdiensten, die Teilnahme

an religiösen Gruppenritualen, gemeinsames Bibelstudium und mehr. Das private Gebet Zuhause, Meditation, das Hören religiöser Musik sind hingegen Beispiele für nichtorganisierte Religiosität (Koenig & Büssing, 2010; Koenig, VanderWeele & Peteet, 2024). Im Rahmen dieser Studie wurde zudem auch die intrinsische und extrinsische Religiosität beobachtet. Eine Person mit hoher intrinsischer Religiosität lebt ihre Religion und übt diese aus innerer Überzeugung heraus aus. Sie verfolgt ihre Religion als ultimatives Ziel an sich, unabhängig von äußeren Belohnungen oder Zielen. Das Ziel ist die spirituelle Verbundenheit und das persönliche Wachstum. Extrinsische Religiosität hingegen sieht diese nur als Mittel zum Erreichen wichtigerer Ziel, wie finanzieller Erfolg, sozialer Status oder Komfort. Eine Person mit hoher extrinsischer Religiosität stellt diese hauptsächlich nur zur Schau, um irdische Vorteile zu genießen (Koenig & Büssing, 2010).

Eine andere Studie des Pew Research Center (2019) untersuchte, ob Religion eine positive, negative oder gemischte Assoziation mit verschiedenen Indikatoren des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefinden aufweist. Sie fanden, dass in den USA und weiteren Ländern die regelmäßige Teilnahme an einer Religionsgemeinschaft mit einem höheren Maß an Zufriedenheit verbunden ist. Das Institut postulierte die Hypothese, dass Gesellschaften, in denen das religiöse Engagement abnimmt, möglicherweise mit einem Rückgang des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefindens konfrontiert sind. Die Religionszugehörigkeit scheint die Wahrscheinlichkeit für persönliches Glück und Wohlbefinden nicht zu beeinflussen (Pew Research Center, 2019).

Schon lange wird in der Wissenschaft diskutiert, wie Religion zu definieren ist. Einige stellen die Frage, ob der Begriff überhaupt eine stabile Kategorie menschlicher Erfahrung beschreibt (Griffiths, 2000; Monroe et al., 2023). The Britannica Dictionary (2024) gibt zwei mögliche Definitionen für Religion: Religion ist „der Glaube an einen Gott oder an eine Gruppe von Göttern“, Religion als „ein organisiertes System von Glaubensvorstellungen, Zeremonien und Regeln, die der Verehrung eines Gottes oder einer Gruppe von Göttern dienen“. Es gibt aber noch viele weitere Definitionen, die sich auf unterschiedliche Aspekte fokussieren, wie es bei Bowker (2003) zu finden ist. Selbst die Etymologie des Wortes hat mehr als einen möglichen Ursprung. In jenen sieht Bowker (2003) dennoch eine gemeinsame Richtung. Alle Definitionen über die Jahrhunderte hinweg sowie die Etymologie und deren Bedeutungen lenken die Aufmerksamkeit auf eines der wichtigsten Merkmale der Religion. Sie ermöglicht es den Menschen, die Welt zu begreifen und sich im Leben zu orientieren (Schneider & Toyka-Seid, 2024). Aus der Sicht der Soziologie haben Religionen schon immer einen Wert gehabt, primär weil sie dem Überleben und der Selektion dienen. Die Religion

ist ein hoch organisiertes Schutzsystem. Die Evolutionspsychologie zeigt, dass Religion und Spiritualität möglicherweise evolutionäre Vorteile bieten, indem sie das Überleben durch soziale Bindungen und Vertrauen fördern. Rituale und religiöse Praktiken können als aufrichtige Signale dienen, die die Kooperation und den Zusammenhalt innerhalb von Gemeinschaften stärken (Norenzayan & Shariff, 2008). Dies trägt zur Erhöhung des individuellen Wohlbefindens und der sozialen Stabilität bei. Für Jahrtausende haben Menschen ein gewisses Religionssystem gehabt, worin die Menschen ihr Leben erfolgreich gelebt haben. Bereits vor 12.000 Jahren bauten frühe Jäger und Sammler beeindruckende Monumente wie Göbekli Tepe, was auf eine weit zurückreichende Glaubenskultur hinweist (Joseph., 2011). Diese historischen Entwicklungen zeigen, dass spirituelle Rituale und Überzeugungen tief in der menschlichen Geschichte verankert sind. Heutzutage zählen sich mehr als drei Viertel der Weltbevölkerung einer Religion zugehörig, unabhängig wie viel oder wenig sie damit zu tun haben (Bowker, 2003).

Spiritualität ist ein sehr komplexes Konstrukt, das sich durch eine wahrgenommene Verbundenheit zum Heiligen oder Transzendenten auszeichnet. Sie geht über das hinaus, was wir sehen oder verstehen können, und beinhaltet existenzielle Fragen wie den Sinn des Lebens (Koenig, 2010). Religion hingegen ist ein System von spezifischen Anschauungen und Praktiken, die sich auf heilige Dinge beziehen und oft institutionell organisiert sind (Durkheim, 1981). Die Verbindung von Spiritualität und Religion zeigt sich darin, dass Spiritualität sowohl innerhalb von Religion existieren kann als auch außerhalb von ihr (Büssing, 2008).

Wie ist die Religion aber von der Spiritualität zu unterscheiden? Es gibt unterschiedliche Modelle, die versuchen zu erklären, wie Religiosität und Spiritualität miteinander interagieren. Koenig (2010) definiert Spiritualität als eng verbunden mit dem Übernatürlichen und Religiösen. Nach seiner Definition ist die Suche nach dem Transzendenten Teil von Spiritualität. Ein Nichtgläubiger gelangt durch sie zum Hinterfragen, dann zum Glauben und schließlich zur Hingabe. Diese Definition von Spiritualität findet sich im Modell des traditionellen Verständnisses von Spiritualität von Koenig et al. (2024). In ihm ist die Spiritualität ein Teil von Religion und Religiosität. *Spirituel* sein dient in diesem Modell zur Beschreibung einer tief religiösen Person. Beim moderneren Verständnis hat sich die Bedeutung von Spiritualität erweitert und umfasst diejenigen, die sich als religiös bezeichnen und jene, die es nicht tun, sich aber als spirituell empfinden. Diese Veränderung hat zu vielen Problemen geführt, um Spiritualität gut definieren zu können, sie von Religiosität soweit zu trennen, dass Personen, die sich

als spirituell, aber nicht religiös identifizieren nicht vernachlässigt werden und letztendlich Spiritualität zu operationalisieren.

Die erfolgreich etablierten Schutzsysteme geben den Menschen Gewissheit und Sicherheit auch andere Dinge zu verfolgen. Dadurch haben sie die Möglichkeiten ihre eigene Natur und Gesellschaften, wie die Welt, die sie umgibt zu erforschen. Die Untersuchung der eigenen Natur schaut zu was der Körper fähig ist zu erleben. Worin liegt sein Potential? Einige Religionen legen den Schwerpunkt aufs Innere des Menschen. Der Buddhismus beispielsweise sucht die Wahrheit im Körper und im Sinne der Erleuchtung, Friede und Leere. Andere Religionen legen den Schwerpunkt aufs Außen. Welchen Wert haben die Dinge außerhalb des Körpers und die Beziehungen mit anderen; deren absoluter Höhepunkt die Gemeinschaft und Vereinigung mit Gott ist? Aus Systemen, die den Wert von Beziehungen untersuchen sind das Judentum, das Christentum und der Islam entsprungen. Dennoch ist festzuhalten, dass beide Systemarten auch den Schwerpunkt des anderen mit betrachtet. Beide erkennen auch die Realität des Bösen und des Schlechten und alle wissen, dass die Erforschung durch den Menschen allein nicht ausreicht und das göttlich dabei unterstützt und fördert (Bowker, 2003). Obwohl verschiedene Religionen wahrhaftig unterschiedlich sind, schützen sie Menschen und vermitteln ihnen wichtige Erkenntnisse in die Möglichkeiten des menschlichen Lebens. All das zeigt, dass Religionen Schutzsysteme sind, die essenzielle Aspekte des menschlichen Lebens und Wohlbefindens bewahren. Die Art und Weise, wie sie funktionieren und wirken, sind eng mit dem Konzept und Praxis der Religion verbunden.

1.1.1.1 Auswirkung auf die Gesundheit

Religionen basieren auf einer eigenen, spezifischen religiösen Logik und beschäftigen sich mit grundlegenden, aber nicht abschließend entscheidbaren Fragen. Diese umfassen Themen wie die Stellung des Menschen in der Welt, das Leben nach dem Tod und die Definition eines „guten Lebens“ sowie moralische Pflichten gemäß den Werten der spezifischen Religionsgemeinschaft. Aufgrund dessen haben Religionen einen erheblichen Einfluss auf Erziehung, Bildung, Handeln und auch auf die Gesundheit und gesundheitsrelevantes Verhalten. Sie bieten ihren Mitgliedern eine umfassende symbolische Weltanschauung und eine Vielzahl spezifischer religiöser Praktiken, die darauf abzielen, den Menschen Orientierung, Sinn und Halt im Leben zu geben. Dieser ganzheitliche

Anspruch spiegelt sich in der Schaffung und Weitergabe eines reichen symbolischen Universums wider, das oft als eine lebensprägende „Erzählung“ oder Narration fungiert. Diese symbolischen und narrativen Strukturen haben häufig eine direkte Relevanz für den Alltag und beeinflussen das Verhalten der Gläubigen. Dazu gehören Vorstellungen von der richtigen sozialen Ordnung, Anstand und Moral, Machtverhältnissen und Ohnmacht, sowie Selbst- und Weltbilder. Zudem prägen Religionen auch körper- und geschlechtsbezogene Rollenbilder sowie Ansichten zu Ernährung und Sexualität (Hemel, 2023). Die Beziehung zwischen Religiosität und Gesundheit ist jedoch komplex und ambivalent. Es gibt sowohl positive als auch negative Auswirkungen, die in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Unumstritten ist, dass schon bevor der Mensch Psychosomatik als solche definierte, in religiösen Weltansichten die körperliche und seelische Gesundheit als verbunden betrachtet wurde und wird.

Sowohl Hemel (2023) als auch Jakobs (2018) betonen, dass Religiosität positive Effekte wie die Förderung sozialer Unterstützung und Gemeinschaftsgefühls sowie die Sinnstiftung hat. Sie fördert die soziale Unterstützung, welche wiederum positive Effekte auf die Gesundheit hat. Außerdem verstärken Religiosität die emotionale und behaviorale Selbstregulation, was zu einem besseren Gesundheitsverhalten und zu günstigeren physiologischen Prozessen führt. Diese Effekte tragen dazu bei, die Häufigkeit von Erkrankungen zu reduzieren und die Mortalität zu senken (Krause, 2015). Religiöse Überzeugungen können Menschen helfen, Krisen zu bewältigen und dem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Andererseits können strikte religiöse Normen zu Schuldgefühlen und Angst führen, und extreme religiöse Praktiken können soziale Isolation und psychische Belastungen verursachen.

Hemel (2023) hebt hervor, dass soziokulturelle Praktiken, die durch Religion vermittelt werden, Schutz und Unterstützung bieten können. Dieser Effekt sei insbesondere bei Frauen gegeben. Allerdings betont er auch, dass restriktive Normen und Rollenbilder die Autonomie und das Wohlbefinden, insbesondere von Frauen, beeinträchtigen können.

Jakobs (2018) konzentriert sich auf die individuelle religiöse Erfahrung und deren Bedeutung für die allgemeine psychische Gesundheit. Er unterstreicht, dass eine positive Religionspädagogik die positiven Effekte der Religiosität verstärken kann. Zusätzliche spezifische negative Effekte gegenüber den allgemeinen Aussagen führt Jakobs nicht an.

Krause (2015) beschreibt, dass das Gebet als häufige Form der spirituellen Praxis sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben

kann. Positive Auswirkungen umfassen die Förderung von Wohlbefinden und die Reduktion von Stress. Negative Auswirkungen können auftreten, wenn Gebete von Angst und Hader geprägt sind oder wenn sie als einzige Bewältigungsstrategie verwendet werden, ohne andere unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. Religiosität wirkt direkt und in ihrer Wirkung positiv auf wichtige Faktoren wie gesundheitsbezogene Lebensqualität, mentale Gesundheit, körperliche Erkrankungen und eine geringere Sterberate aus. Studien zeigen, dass religiöse Praktiken das Auftreten von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Infarkten und Schmerzen verringern können. Außerdem fördern sie positives Gesundheitsverhalten und das Langzeitüberleben. Hoffnung ist ein wichtiger Faktor für das psychische Wohlbefinden und wirkt als Puffer gegen psychische Erkrankungen. Sie hängt mit einem höheren Selbstwertgefühl, mehr positiven Gefühlen und einem besseren subjektiven Wohlbefinden zusammen. In Zeiten von Krankheit und Krisen stellt Hoffnung eine wertvolle Ressource dar (Krause, 2015).

1.1.2 Kultur

Was ist Kultur? Bowker (2003) beschreibt es als zweite Schutzhaut des Replikationsprozesses. Wir Menschen sind als Lebewesen darauf ausgerichtet unsere Spezies am Leben zu erhalten. Jene mit guten Genen überleben besser und pflanzen sich vermehrt fort als solche mit benachteiligten Eigenschaften. In seiner Erklärung, was Kultur ist, beschreibt Bowker (2003) unsere Haut als den ersten Schutzmechanismus für den Genreplikationsprozess. Da wir jedoch soziale und intelligente Wesen sind haben wir ein weiteres Verteidigungssystem implementiert, das sich außerhalb der Grenzen unseres Körpers befindet; die gemeinsamen kulturellen Errungenschaften. Die Kultur schützt uns demzufolge vor dem Aussterben. Religionen haben sich in den vielen, damals stark von einander getrennte, Kulturen sehr früh als kulturelles System entwickelt, um die Gruppe zu erhalten. Wie lassen sich Religion und Kultur voneinander trennen? Es ist wichtig festzuhalten, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können und dies auch tun. Stark säkulare Länder und Kulturen lassen, durch ihre säkularen Institutionen und Angeboten für viele Menschen Religion weniger notwendig erscheinen (Cohen, 2015). So, wie Durkheim (1915) Religion definiert, ist sie von der Kultur nicht zu trennen, da ihre Überzeugungen und Praktiken kulturell geprägt sind. Vor vielen Jahrhunderten diktierten die Religionsoberhäupter in Europa die Politik. Von diesem Standpunkt aus ist es nachvollziehbar, dass Kultur und Religion sehr eng miteinander verwoben sind. Die enge

Verknüpfung zwischen Kultur und Religion ist jedoch nicht allein auf das Christentum und die westliche Welt zu übertragen. Auch für östliche Religionen, wie dem Buddhismus und dem Islam prägen die religiösen Philosophien die Kultur und umgekehrt (Croucher, Zeng, Rahmani & Sommer, 2017). Doch ist dies heutzutage noch aktuell? In Europa beispielsweise schreitet die Sekularisierung, die Trennung von Kirche und Staat immer weiter voran. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg die Individualisierung der Gesellschaft an und zugleich verloren jüdisch-christliche Institutionen ihre Autorität. Dies hat jedoch der Religion nicht die wichtige Rolle entzogen, in schwierigen und schmerzhaften Zeiten eine Quelle der Kraft und des Haltes zu sein (Croucher et al., 2017). Obwohl Religion und Kultur interagieren, heißt es nicht, dass sie das gleiche abbilden, oder das gleiche aussagen. Keine Religion der Welt umfasst eine ganze Gesellschaft und keine Gesellschaft richtet sich allein nach religiösen Vorschriften und Praktiken. Es ist sinnvoll, die beiden als miteinander verbunden zu betrachten und ihre Wechselwirkungen zu analysieren (McGlichey, Waters & Scheinpflug, 2023).

1.1.2.1 Operationalisierung von Kultur

Wenn Kultur und Religion nicht von einander trennbar ist, wie lässt sich dann Kultur beobachten? Hofstede (2001) entwickelte sechs Kulturdimensionen, mit denen sich unterschiedliche Kulturen vergleichen und beschreiben lassen. Dafür definierte Hofstede Kultur vereinfacht als „Software des Geistes“ (Hofstede, 2001, S. 209). Laut ihm setzt sich eine Kultur aus diesen nachfolgenden sechs Dimensionen zusammen und ermöglicht es Kulturen zu vergleichen.

Die *Machtdistanz* beschreibt die Akzeptanz der Machtverteilung. In Kulturen mit hoher Machtdistanz werden starke Hierarchien akzeptiert, in denen beispielsweise Führungskräfte Entscheidungen treffen, die nicht in Frage gestellt werden. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Kulturen mit einer niedrigen Machtdistanz durch flache Hierarchien aus, in denen Menschen eher auf gleicher Augenhöhe miteinander interagieren (Knecht, 2020).

Die zweite Dimension der *Individualismus* beschreibt die Stärke der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb einer Kultur. In individualistisch geprägten Gesellschaften sind diese Bindungen eher locker, wobei das Individuum im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz dazu steht in kollektivistischen Kulturen das Kollektiv im Vordergrund, wobei Loyalität, Fürsorge und Harmonie wichtige Merkmale sind (Knecht,

2020).

Maskulinität stellt die dritte Dimension da und beschreibt das Ausmaß, in dem eine Kultur die traditionelle Aufteilung der Geschlechterrollen akzeptiert. In maskulinen Gesellschaften sind diese Rollen klar definiert, während in femininen Kulturen die Rollen flexibler sein können. Darüber hinaus zeichnen sich maskuline Kulturen durch Betonung von Status, Macht und Prestige aus, während feminine Kulturen eher von Fürsorge und Empathie geprägt sind (Knecht, 2020).

Die *Unsicherheitsvermeidung* beschreibt das Ausmaß, in dem eine Gesellschaft Risiken scheut und sich gegenüber Veränderungen und Innovationen zurückhaltend verhält. Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung bevorzugen bewährte Muster und versuchen, Unsicherheiten durch Regeln und Vorschriften zu minimieren (Knecht, 2020).

Die fünfte Dimension *Langzeitorientierung* beschreibt, ob eine Kultur dazu neigt, langfristige Ziele zu planen und zu verfolgen oder eher spontan und kurzfristig handelt und denkt (Knecht, 2020).

Die sechste und letzte Dimension *Genuss* zeigt an, inwieweit eine Kultur die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen akzeptiert. In Kulturen mit hoher Indulgenz werden auch Randgruppen oder Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechen, akzeptiert und die Freiheit wird als wichtiger Wert angesehen. In Kulturen mit niedriger Indulgenz sind die Regeln und Normen hingegen strikter (Knecht, 2020).

Wilczewski et al. (2023) und weitere nutzen die Individualismus-Kollektivismus Dimension um Kulturen in wissenschaftlichen Studien zu vergleichen. Wie bereits in der kurzen Beschreibung der Dimension geschildert, bildet sie die Beziehung des Individuums zur Gesellschaft ab. Steht das Individuum in einer engen Beziehung zu anderen entspricht dies für Kollektivismus. Ist die Beziehung zwischen Individuum und anderen Gesellschaftsmitgliedern loser, dann entspricht dies dem Individualismus (Hofstede, 2001). Individualismus bedeutet aber nicht Egoismus, vielmehr, dass das Individuum eigene Entscheidungen trifft (Hofstede, 2024). Ein Beispiel dafür ist die USA, in der die Unabhängigkeit und Autonomie des Individuums wertgeschätzt wird (Utler, 2020). Auf der anderen Seite bedeutet Kollektivismus nicht Verbundenheit. Es ist viel mehr, dass jede Personen ihren Platz im Leben kennt, der durch die Gesellschaft bestimmt wird (Hofstede, 2024). China oder Pakistan sind Beispiele dafür. Dort stellt die Person ihre eigenen Ziele hinter die Ziele der sozialen Gruppe, wie Arbeit oder Familie. Da dies für alle Mitglieder der Gesellschaft gilt, erhalten sie von ihr bedingungslose Unterstützung und Schutz. Auf familiärer Ebene steht die Kernfamilie aus Mutter, Vater, Kind für

individualistische und die Großfamilie für kollektivistische Gesellschaften (Utler, 2020).

1.1.2.2 Auswirkung auf die Gesundheit

Die Bedeutung und das Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Wohlbefinden sind kulturell geprägt. Dies umfasst, wie Menschen ihre Gesundheit einschätzen, wie sie Symptome interpretieren und wie sie mit gesundheitlichen Herausforderungen umgehen. Diese Verhaltensweisen werden durch kulturelle Normen und Überzeugungen geprägt (Hernandez & Gibb, 2019; Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). Sie beeinflusst die Einstellungen, die Personen zu den verfügbaren Gesundheitsmaßnahmen wie Impfprogrammen, oder Psychotherapie haben und wie sie auf solche Maßnahmen reagieren und kann somit den Erfolg oder das Scheitern dieser Interventionen bestimmen (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024).

In vielen Kulturen werden psychische Leiden häufig stigmatisiert oder als körperliche Beschwerden interpretiert, was zu Verzögerungen bei der Suche nach professioneller Hilfe führen kann. Beispielsweise neigen kollektivistische Kulturen, wie China dazu, psychische Probleme zu verschweigen, was zu einer Unterbehandlung führen kann (Hernandez & Gibb, 2019). Da dem Individuum weniger Bedeutung beigemessen wird als beispielsweise der Familie, werden psychische Erkrankungen als Scheitern der Gruppe gesehen. Um das Ansehen der Familie nicht zu beschädigen, werden die Erkrankungen und Beschwerden oft verheimlicht (Karasz et al., 2019).

Kulturelle Prägungen spielen im Umgang mit Gesundheitsthemen eine große Rolle. Sie bestimmen, wie und ob Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben. Sie beeinflussen, welche Gesundheitsdienste in Anspruch genommen werden und wie diese genutzt werden (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). So wird im ostasiatischen Raum der Fokus eher auf das Wohl der Gemeinschaft gelegt als auf das Individuum, was sich auf die Gesundheitspraktiken und die Interaktion mit dem Gesundheitssystem auswirkt. In islamischen Gesellschaften kann die Tabuisierung bestimmter Gesundheitsthemen die Gesundheitskompetenz und die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten negativ beeinflussen (Wielga & Knospe, 2023).

Trotz gesundheitlicher Probleme und wirtschaftlicher Härten kann die Kultur einer Gemeinschaft deren Widerstandsfähigkeit stärken und zu einem besseren Wohlbefinden beitragen (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). Des Weiteren können durch kulturelle Praktiken die Bindung zur Gemeinschaft gefördert werden.

Gemeinschaften, die durch gemeinsame kulturelle Traditionen verbunden sind, bieten ihren Mitgliedern ein Gefühl der Zugehörigkeit und emotionaler Unterstützung. Die Gemeinschaft kann in Zeiten von Stress oder Krankheit soziale Unterstützung bieten, was die psychische Gesundheit schützt und stärkt. Kulturelle Praktiken bieten auch physischen Schutz. Dank des Begräbnisrituals der Acholi in Uganda konnten die Ausbreitung der Infektionskrankheit begrenzt werden (Hewlett & Hewlett, 2008).

1.1.3 Wohlbefinden

Die World Health Organization (1948) definiert „Gesundheit als einen Zustand vollkommenem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ (S. 01). In Anlehnung an diese Definition hat der Begriff des Wohlbefindens zahlreiche Präzisierungsversuche durch verschiedene Disziplinen erfahren. Gesundheit und Wohlbefinden werden oft undifferenziert in einem Atemzug genannt. Trojan und Legewie (2001) argumentieren jedoch, dass Wohlbefinden im Unterschied zur Gesundheit einen äußerst komplexen subjektiven Bewusstseinszustand darstellt, der sich grundsätzlich einer direkten äußeren Beobachtung entzieht. Diese subjektive Dimension wird auch in der Beschreibung von Mayring (1991) deutlich, demzufolge Wohlbefinden durch vier Faktoren charakterisiert wird:

1. Freiheit von Belastungen im Sinne einer Abwesenheit subjektiver Belastungen, Krankheitssymptomen und negativer Gefühle.
2. Erleben von Freude im Alltag, ausgedrückt durch kurzfristige positive Gefühle.
3. Zufriedenheit, die aus dem Abwägen positiver und negativer Lebensaspekte resultiert.
4. Empfinden von Glück, das über den konkreten Moment hinausgeht und mit einem insgesamt positiven Lebensgefühl verbunden ist.

Der subjektive Gesundheitszustand dient auch als verlässliches Indiz für die objektive gesundheitliche Lage (Hornberg, 2016).

Die Definition des mehrdimensionalen Wohlbefindens ist komplex und interdisziplinär. Wissenschaftler im Bereich der Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften haben verschiedene Definitionen aufgestellt, die im Kern jedoch auf einen gemeinsamen Nenner treffen. Wohlbefinden umfasst subjektive und objektive

Dimensionen und beinhaltet sowohl individuelle Erfahrungen als auch den Vergleich der Lebensumstände mit sozialen Normen und Werten (Dhanabhakyaam & Sarath, 2023; Röhrle, 2023). Das vielschichtige Konstrukt umfasst emotionale, psychologische und soziale Dimensionen. Es beinhaltet positive Emotionen (wie Glück und Zufriedenheit), das Fehlen negativer Emotionen (wie Depression und Angst), Lebenszufriedenheit und einen Zweck im Leben, Erfüllung und positives Funktionieren, Autonomie, positive Beziehungen und persönliches Wachstum (Dhanabhakyaam & Sarath, 2023; Sischka, Costa, Steffgen & Schmidt, 2020a). Es schließt sowohl affektive Komponenten (positive und negative Gefühle) als auch kognitive Bewertungen (Lebenszufriedenheit) ein (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Nelson, Kushlev & Lyubomirsky, 2014). In der Psychologie wird Wohlbefinden allgemein als ein positiver und wünschenswerter Zustand betrachtet, im Gegensatz zu Unwohlsein, das als negativ und unerwünscht gilt (Lucas, 2016).

Positives emotionales Befinden gilt als Überbegriff für das subjektiv empfundene Wohlbefinden. Freude und Glück, die oft in Verbindung mit Wohlbefinden gebracht werden, sind verschiedene Erscheinungsformen dessen. Dabei wird zwischen aktuellen, situationsspezifischen emotionalen Zuständen (states) und langandauernden, übergreifenden emotionalen Zuständen als Persönlichkeitseigenschaften (traits) differenziert. Freude wird als state verstanden (Mayring, 1991). Es ist ein emotionaler Zustand, der früh in der menschlichen Entwicklung auftritt. Durch soziale Interaktionen wird diese vertieft. Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Selbstvertrauen, Anerkennung, Zufriedenheit, Sicherheit und das Gefühl, geliebt zu werden (Izard, 1994). Glück hingegen besitzt sowohl eine state- als auch als trait-Komponente. Auch Glück wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Hoffmann (1984) identifiziert unter anderem die Qualität menschlicher Beziehungen, schöpferische Kraft, Öffnung der Sinne, Erotik, Ruhe und Entspannung sowie die Bejahung von Leben und Sinnhaftigkeit des Lebens als wichtige Komponenten. Glück wird jedoch eher als trait verstanden, das über den Lebenslauf aufgebaut wird (Mayring, 1991).

In dieser Arbeit wird die subjektive Dimension des Wohlbefindens betrachtet. Das subjektive Wohlbefinden (SWB) ist ein umfassender Begriff, der sowohl emotionale Reaktionen, Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen als auch globale Lebenszufriedenheit umfasst. Dabei handelt es sich um eine weit gefasste Kategorie von Phänomenen, die die emotionalen Reaktionen der Menschen, die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen und die globalen Urteile über die Lebenszufriedenheit einschließt (Diener et al., 1999). Es wird stark mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (2000) verknüpft, die drei zentrale menschliche Grundbedürfnisse betont:

Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Diese Bedürfnisse sind entscheidend für das Wohlbefinden, da ihre Befriedigung zu einem tiefen Gefühl von Vitalität, psychischer Gesundheit und Lebenszufriedenheit führt (Deci & Ryan, 2000; Ng et al., 2012). Davon wird von manchen Autoren das psychische Wohlbefinden (PWB) unterschieden. Es beinhaltet die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität, einschließlich der Abwesenheit von psychischen Störungen wie Depression und Angst. Aber auch positive psychologische Funktionen wie Selbstakzeptanz, Sinnhaftigkeit, persönliches Wachstum und Autonomie gehören dazu. Das PWB wird auch im Kontext von SWB als Teilmenge betrachtet, das die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität umfasst. PWB kann als eine Dimension des SWB gesehen werden, da es stark auf den emotionalen und kognitiven Bewertungen des Individuums basiert (Maly-Motta, 2023). In der psychologischen Literatur werden SWB und PWB oft synonym verwendet, insbesondere wenn es darum geht, das allgemeine Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit zu bewerten. Beide Begriffe beziehen sich auf die persönliche Bewertung des eigenen Lebens und die Emotionen, die mit diesen Bewertungen verbunden sind (Diener et al., 1999). Das et al. (2020) diskutieren verschiedene Theorien des SWB, die von psychologischen Mechanismen beeinflusst werden. Diese Theorien betonen, wie sowohl interne als auch externe Faktoren das individuelle SWB beeinflussen, und integrieren Konzepte wie persönliches Wachstum, Zielerreichung und emotionale Zustände als wesentliche Bestandteile des PWB. Diener, Oishi und Lucas (2009) behandeln SWB umfassend und beschreiben es als kognitive und affektive Bewertungen des Lebens einer Person. Es wird oft in Verbindung mit Konzepten wie Lebenszufriedenheit und emotionalen Reaktionen auf Lebensereignisse untersucht, was zeigt, dass SWB und PWB häufig austauschbar verwendet werden.

1.1.3.1 Biopsychosoziales Modell

Das biopsychosoziale Modell, entwickelt von Engel (1977) in den 1970er Jahren, bietet einen umfassenden Rahmen zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit und Krankheit. Es integriert biologische, psychologische und soziale Faktoren und betont deren wechselseitige Beeinflussung. Während biologische Aspekte die genetischen, neurobiologischen und physiologischen Grundlagen umfassen, beinhalten psychologische Faktoren Kognition, Emotion und Verhalten. Soziale Einflüsse beziehen sich auf soziale Netzwerke, kulturelle Werte und gesellschaftliche Strukturen. Diese ganzheitliche

Perspektive ermöglicht es, komplexe Gesundheitsprobleme besser zu verstehen (Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004).

Biologische Einflüsse: Wohlbefinden hat einen inneren und instrumentellen Wert und ist integraler Bestandteil der Gesundheit. Biologische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle für das psychische Wohlbefinden. Genetische Veranlagungen, neurobiologische Mechanismen, Hormonspiegel und körperliche Gesundheit beeinflussen, wie Menschen auf Stress und Lebensereignisse reagieren. Beispielsweise können chronische Krankheiten, hormonelle Ungleichgewichte oder neurochemische Dysfunktionen das Wohlbefinden beeinträchtigen und zu psychischen Gesundheitsproblemen führen (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles & Glaser, 2002; Sapolsky, 2004).

Psychologische Einflüsse: Psychologische Faktoren wie individuelle Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeit und emotionale Intelligenz beeinflussen ebenfalls das Wohlbefinden. Resilienz spielt eine wichtige Rolle, obwohl Menschen, die widrigen Umständen ausgesetzt sind, einem höheren Risiko für psychische Gesundheitsprobleme ausgesetzt sind. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und sich von Rückschlägen zu erholen, hängt stark von den kognitiven und emotionalen Ressourcen ab, die eine Person mobilisieren kann (Bandura, 1997; Carver, 2010).

Soziale Einflüsse: Äußere Anforderungen und kritische Lebensereignisse können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser Ereignisse spielen eine entscheidende Rolle für das individuelle Wohlbefinden. Stressoren, die als bedrohlich oder belastend wahrgenommen werden, können zu einer Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens führen, was sich in physischen und psychischen Gesundheitsproblemen manifestieren kann. Darüber hinaus sind soziale Unterstützung und stabile Beziehungen wichtige Ressourcen, die das Wohlbefinden stärken und die Resilienz gegenüber Stress erhöhen können (Lazarus & Folkman, 1987; Pearlin, 2010; Uchino, 2006). Kultur und Religiosität sind wesentliche soziale Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen können. Diese Elemente spielen eine Rolle in der Art und Weise, wie Menschen Stress wahrnehmen und bewältigen, welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln und wie sie soziale Unterstützung suchen und erhalten (Matsumoto & Juang, 2016).

Kulturelle Werte und Normen prägen das Verständnis von Wohlbefinden und Gesundheit. Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was es bedeutet, psychisch gesund zu sein, und welche Verhaltensweisen als gesundheitsfördernd gelten. Kulturelle Hintergründe beeinflussen auch die soziale Unterstützung, die Menschen

erhalten, sowie die Stigmatisierung von psychischen Gesundheitsproblemen (Triandis, 1994). Wie bereits in Kapitel 1.1.1.1 aufgeführt, kann Religiosität als Ressource für das Wohlbefinden dienen, indem sie den Menschen einen Sinn im Leben gibt, soziale Unterstützung bieten und Bewältigungsstrategien fördert. Religionsgemeinschaften können soziale Netzwerke bereitstellen, die emotionale Unterstützung bieten und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken. Darüber hinaus können religiöse Praktiken wie Gebet oder Meditation stressmindernd wirken und das psychische Wohlbefinden fördern (Koenig, 2012; Pargament, 1997).

1.2 Aktueller Forschungsstand

In dieser Studie wird folgende Frage untersucht: Hat der Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden einen kulturellen Unterschied?

In den folgenden drei Unterkapiteln 1.2.1 Hypothese 1, 1.2.2 Hypothese 2 und 1.2.3 Hypothese 3 erfolgt die Herleitung der zu untersuchenden Hypothesen auf Basis bereits bestehender Befunde.

1.2.1 Hypothese 1

Religiosität und Wohlbefinden sind zwei Konzepte, die in der psychologischen Forschung häufig untersucht wurden. Es gibt zahlreiche Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Dimensionen von Religiosität und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens belegen. Diese Beziehung wird oft auf Faktoren wie soziale Unterstützung, Sinnfindung im Leben und Bewältigungsmechanismen zurückgeführt, die mit religiösen Praktiken und Überzeugungen einhergehen.

Die erste Hypothese überprüft, ob das religiöse Engagement und religiöse Aktivitäten positiv mit Wohlbefinden korrelieren. Diese Aussage wird durch bereits bestehende Ergebnisse unterstützt. Eine Studie von Dar und Iqbal (2019) zeigte eine positive Assoziation zwischen religiösem Engagement und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens, einschließlich Lebenszufriedenheit, Glück und Optimismus (vgl. Kapitel 1.1.3). Der totale Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden betrug $B = .39$ ($p < .001$) und der direkte Effekt einen Wert von $B = .28$ ($p < .050$). Dies zeigt, dass ein Teil des Einflusses von Religiosität auf das Wohlbefinden ohne andere Faktoren besteht. Auch bivariate Analysen von Koenig und Al Shohaib (2024) zeigen eine positive Assoziation zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($r = .12$), Glück

($r = .13$) und Optimismus ($r = .19$), was als kleiner bis mittlerer Effekt bewertet wird. Multivariate Analysen bestätigten diese Ergebnisse und zeigen signifikante Beziehungen zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$), wobei ebenfalls kleine bis mittlere Effekte nachgewiesen wurden.

Van Cappellen, Toth-Gauthier, Saroglou und Fredrickson (2016) wiesen auf, dass allgemeine Religiosität in einer positiven Beziehung zum Wohlbefinden ($B = .11$, $SE = .03$, $p < .010$) steht. Auch die häufige Teilnahme an religiösen Aktivitäten scheint mit höheren Werten des Wohlbefindens zusammenzuhängen. Jokela (2022) wies eine moderate positive Korrelation zwischen psychischen Wohlbefinden und religiöser Teilnahme ($B = 0.29$; 95% CI [0.14, 0.45]) sowie allgemeiner Religiosität ($B = 0.37$; CI [0.21, 0.53]) auf. Des Weiteren zeigen seine Ergebnisse eine moderate negative Korrelation mit psychischem Stress auf ($B = -0.11$; CI [-0.16, -0.06] für Religiosität und $B = -0.14$; CI [-0.19, -0.09] für religiöse Teilnahme), die sich wiederum auf die psychische Gesundheit und damit auf das Wohlbefinden auswirken. In dieser Studie wurden zudem monotone Assoziationen zwischen religiöser Teilnahme und psychischem Stress sowie Wohlbefinden festgestellt. Dies bedeutet, dass mit zunehmender religiöser Teilnahme sowohl der psychische Stress abnimmt als auch das psychische Wohlbefinden steigt. Ebenso gab es monotone Assoziationen zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden (Jokela, 2022). So wie psychischer Stress haben depressive und ängstliche Symptomatik einen negativen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Fernández und Rosell (2022) untersuchten dessen Zusammenhang mit Religiosität im Sinne von organisierter Religiosität und intrinsischer Religiosität. Die Ergebnisse zeigen eine negative Assoziation von organisierter Religiosität mit depressiver Symptomatik ($\beta = -.08$; $p = .001$). Die intrinsische Religiosität korreliert ebenfalls negativ mit ängstlicher Symptomatik ($\beta = -.07$; $p = .002$). Diese Effekte sind zwar klein, aber signifikant.

1.2.2 Hypothese 2

Die Forschung zeigt, dass Wohlbefinden positiv mit Religiosität zusammenhängt. Solche Beziehungen treten zudem in verschiedenen Kulturen auf, in denen Menschen unterschiedlichen Glaubensrichtungen folgen (Graham & Crown, 2014; Tay, Li, Myers & Diener, 2014). Der Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen der Religiosität und dem Wohlbefinden sind Bestandteil der zweiten Hypothese.

In kollektivistischen Kulturen, die stärker auf Familiennetzwerke und gemeinschaftliche Bindungen fokussiert sind, könnte der Einfluss von intrinsischer Religiosität auf das Wohlbefinden durch das Familiennetzwerk besonders stark ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Familiennetzwerk ($\beta = -0.012$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.005$ für ängstliche Symptomatik) unterstützen diese Annahme. In individualistischen Kulturen, in denen persönliche Freundschaften und individuelle Netzwerke eine größere Rolle spielen, könnte der Einfluss von organisierter Religiosität auf das Wohlbefinden durch Freundesnetzwerke stärker ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Freundesnetzwerk ($\beta = -0.007$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.002$ für ängstliche Symptomatik) deuten darauf hin, dass Freundschaften in diesen Kulturen eine wichtige Rolle spielen. Diese Mediationseffekte legen nahe, dass Kultur einen moderierenden Effekt auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden haben könnte. In kollektivistischen Kulturen könnte intrinsische Religiosität über starke Familiennetzwerke einen größeren positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben, während in individualistischen Kulturen organisierte Religiosität über Freundesnetzwerke eine wichtigere Rolle spielen könnte. Diese Spekulationen könnten in zukünftigen Studien weiter untersucht werden, um den Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden genauer zu verstehen. (Fernández & Rosell, 2022)

In der Studie von Hoogeveen et al. (2022) wurde der Einfluss kultureller Normen auf die Beziehung zwischen Religiosität und selbstberichteter Lebenszufriedenheit untersucht. Von 101 Teams berichteten 97 positive Beta-Koeffizienten, wobei 65% der Konfidenzintervalle den Wert Null ausschlossen. Der Median der Effektgröße betrug .039, was einem kleinen, aber positiven Effekt entspricht. Die Median Absolute Deviation von 0.022 weist darauf hin, dass die Streuung der Effektgrößen relativ gering ist, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse weiter unterstützt. Zudem kamen 54% der Teams zu dem Schluss, dass kulturelle Normen einen signifikanten Einfluss haben. Insbesondere die Tatsache, dass der Median der berichteten Effektgrößen positiv ist und dass ein signifikanter Anteil der Konfidenzintervalle den Wert Null ausschließt, unterstützt die Annahme, dass kulturelle Normen einen moderierenden Effekt haben. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um zu argumentieren, dass kulturelle Unterschiede, wie sie in der Dimension Individualismus-Kollektivismus definiert sind, ebenfalls einen solchen moderierenden Effekt haben könnten.

Diese Ergebnisse können für die Untersuchung der Hypothese, dass Kultur einen

Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat, besonders im Hinblick auf die Unterscheidung von Kulturen auf der Dimension Individualismus-Kollektivismus, herangezogen werden. Die in der Studie von Fernández und Rosell (2022) und Hoozevee et al. (2022) berichteten statistischen Kennwerte zeigen, dass die Kultur einen signifikanten Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden haben können.

1.2.3 Hypothese 3

In der Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden geschlechtsabhängig ist. Studien haben gezeigt, dass diese Zusammenhänge unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.

Koenig und Al Shohaib (2024) fanden in ihrer Untersuchung eine signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und Religiosität in Bezug auf die Lebenszufriedenheit ($B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Ähnliche Trends wurden auch für Glück und Optimismus beobachtet, wobei die Beziehung zwischen allgemeiner Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$) ebenfalls stärker bei Männern ausgeprägt war (Interaktionseffekt $B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$).

Dar und Iqbal (2019) erweiterten diese Erkenntnisse, indem sie die Rolle des Gefühls von Bedeutung als vermittelnden Faktor zwischen religiöser Verpflichtung und Wohlbefinden untersuchten. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das Gefühl von Bedeutung eine signifikante vermittelnde Rolle spielt, insbesondere bei Mädchen. Der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden über das Gefühl von Bedeutung hatte einen Punktwert von 0,0768 und ein 95%-Konfidenzintervall von 0,0074 bis 0,1675, was auf eine kleine bis mittlere Effektstärke hinweist ($k^2 = 0,068$, 95%-BCa-CI [0.014, 0.160]). Bei der geschlechtsspezifischen Analyse zeigte sich, dass der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden bei Mädchen stark und signifikant war (Punktwert = 0,1568, 95%-CI = 0,0527 bis 0,3188), während er bei Jungen schwach und nicht signifikant war (Punktwert = 0,0103, 95%-CI = -0,0848 bis 0,1061).

Die Studie von Lazar und Bjorck (2016) untersuchte die Auswirkungen verschiedener Formen religiöser Unterstützung auf das Wohlbefinden und zeigte, dass Geschlecht eine

moderierende Rolle spielt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft stärker mit Lebenszufriedenheit bei Frauen ($\beta = .28, p < .01$) als bei Männern ($\beta = .13, p < .01$) assoziiert war und dass RCS bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = .25, p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.07, ns$). Die Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft lässt sich mit der Dimension der organisierten Religiosität vergleichen, da beide die Teilnahme an gemeinschaftlichen religiösen Praktiken umfasst. Auch ein Geschlechterunterschied bei der intrinsischen Religiosität kann durch die Ergebnisse der Autoren vermutet werden. Intrinsische Religiosität bezieht sich auf die persönliche Motivation und den inneren Glauben einer Person, was der in der Studie von Lazar und Bjorck (2016) gemessenen Unterstützung durch religiöse Führer nahekommt. Die Studie fand heraus, dass Unterstützung durch religiöse Führer insbesondere bei Frauen eine stärkere positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit hatte ($\beta = .20, p < .01$) als bei Männern ($\beta = .09, p < .05$), und dass SLS bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = -.17, p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.04, ns$).

Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass Geschlecht den Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden moderiert.

2 Methoden

In diesem Kapitel wird die empirische Bearbeitung der Hypothesen dargestellt. Zunächst wird die erhobene Stichprobe beschrieben, gefolgt von der Erläuterung der Erhebungsmethode, der Stichprobenauswahl und dem Erhebungsdesign. Darauf folgend wird auf die Operationalisierung der Konstrukte eingegangen. In folgendem Zuge wird die Untersuchungsdurchführung konkretisiert und abschließend wird auf die Auswertungsmethode eingegangen.

2.1 Stichprobenbeschreibung

Von den xx Probanden, die an der Onlinebefragung teilgenommen haben, mussten xx entfernt werden, da sie den Fragebogen nicht vollständig beantworteten. Somit nahmen am Onlinefragbogen eine Stichprobe von $N = 111$ Probanden teil. Weibliche Teilnehmer bilden mit $n = 111$ (xx%) den größten Teil der Gesamtstichprobe ab. Männliche Teilnehmer betrugen xx% ($n = 125$) der Befragten. Des Weiteren gaben 0.5% ($n = 2$) der Probanden an ein diverses Geschlecht zu haben. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei $M = 33.52$ Jahren ($SD = 13.67$). Eine grafische Darstellung der Altersverteilung ist in Abbildung zu sehen. An ihr lässt sich ablesen, dass der jüngste Teilnehmer 18 Jahre alt war, der älteste betrug ein Alter von 77 Jahren. Da sich ein großer Teil der Probanden aus Studierenden zusammensetzt, liegt die größte Anhäufung der Teilnehmer bei 21 Jahren. Es handelt sich dabei um eine unimodale und rechtsschiefe Verteilung.

2.2 Untersuchungsdesign

Bei dieser Studie handelt sich um ein quantitatives Querschnittstudie mit einer anfallenden Stichprobe, um eine Momentaufnahme des Zusammenhangs zwischen den unterschiedlichen Variablen zu liefern. Die Datengeneration wurde mithilfe eines Onlinefragbogens erstellt, da dadurch eine weitreichendere und ökonomischere Erhebung gewährleistet werden konnte. Auf diese Weise konnten der Interview- und der Versuchsleitereffekt vermieden werden. Der Zugangslink wurde primär über die sozialen Netzwerke verschickt der sich nach dem Prinzip des Schneeballeffekts verbreitete.

Der Fragebogen war auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar, um Probanden mit anderen kulturellen Hintergründen zu erreichen. Um eine gute Durchführung für die

Teilnehmer gewährleisten zu können, wurde vor Veröffentlichung des Fragebogens ein Pretest in den drei Sprachen durchgeführt.

Vorraussetzung für die Teilhabe an der Umfrage waren ein internetfähiges Endgerät, ein Mindestalter von 12 Jahren und eine ausreichende Beherrschung mindestens einer der drei Sprachen. Die gewünschte Sprache konnte zu Beginn der Befragung ausgewählt werden.

2.3 Operationalisierung der Konstrukte

Die untersuchten Variablen wurden mithilfe standardisierter Fragebögen erhoben. Die Befragung begann mit zwei Fragebögen zur Religiosität. Die Deutsche Version der Religious Commitment Scale von Klumpparendt und Drenckhan (2014) misst die Verbundenheit einer Person mit ihrer Religion. Neben einer deutschen Version wurde auch eine englische Übersetzung des Fragebogens von den Autoren veröffentlicht. Um ihn für diese Studie nutzen zu können, wurde er ins Spanische übersetzt. Für diese Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine Sinngemäße Übersetzung handelt wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. Die Faktorladungen der fünf Items auf einen gemeinsamen Faktor liegen bei .81 bis .92. Dies spricht für eine gute Konstruktvalidität und eine gute Reliabilität (Klumparendt & Drenckhan, 2014). Auf einer siebenstufigen Antwortskala von 0 = *gar nicht* bis 6 = *sehr* konnten die Fragen beantwortet werden. Ein Beispielitem des Fragebogens lautet wie folgt: „Wie ausgeprägt leben Sie nach den Erfordernissen Ihrer Religion oder Ihres Glaubens?“.

Der zweite Fragebogen bezüglich der Religiosität war der Duke University Religion Index (DUREL) von Koenig, Parkerson und Meador (1997). Dieser erhebt drei unterschiedliche Aspekte von Religiosität: Organisierte religiöse Aktivitäten, Nichtorganisierte religiöse Aktivitäten und Intrinsische Religiosität. Das erste Item „Wie oft besuchen Sie den Tempel Ihrer Religion oder andere religiöse Treffen?“ misst auf einer sechsstufigen Skala mit 1 = *Nie*, 2 = *Einmal im Jahr oder weniger*, 3 = *Einige Male im Jahr*, 4 = *Einige Male im Monat*, 5 = *Einmal pro Woche* und 6 = *Mehr als einmal pro Woche* organisierte religiöse Aktivitäten. Auf der gleichen Skala misst das zweite Item „Wie oft widmen Sie sich privaten religiösen Aktivitäten wie Gebet, Meditation oder wie oft setzen Sie sich mit den Schriften Ihrer Religion auseinander?“ nichtorganisierte religiöse Aktivitäten. Die anderen drei Items bilden die dritte Subskala, die die intrinsische Religiosität misst. Hierfür wird eine fünfstufige Antwortskala genutzt, die von

1 = *Stimme überhaupt nicht zu*, 2 = *Stimme wenig zu*, 3 = *Neutral*, 4 = *Stimme etwas zu* bis hin zu 5 = *Stimme vollkommen zu* reicht. Ein Beispiel für solch ein Item ist folgendes: „Meine religiösen Überzeugungen sind das, was wirklich hinter meinem gesamten Lebensansatz steht.“. Die Autoren veröffentlichten eine Englische und Spanische Version. Für diese Studie wurden die Fragen ins Deutsche übersetzt und die spanische Version wurde überarbeitet. Für die deutsche Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine Sinngemäße Übersetzung handelt wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. In einer Validierungsstudie von Koenig und Büssing (2010) wurde eine hohe Retestreliabilität (Intra-Klassen-Korrelation = .91) und eine hohe Konsistenz (Cronbachs- α = .78-.91) ermittelt. Der DUREL hat zudem eine hohe konvergente Validität mit anderen Messungen der Religiosität (r = .71-.86).

Im Anschluss erfolgte der WHO-5 Fragebogen zum Wohlbefinden (World Health Organization, 1998), der die Befragten betreffend ihres Wohlbefindenes der letzten zwei Wochen befragte. Das Präfix „In den letzten zwei Wochen...“ leitet die fünf Items, wie beispielsweise „... war ich froh und guter Laune“ ein. Für die Bearbeitung der Items steht eine sechsstufige Skala zur Verfügung, die von 1 = *Die ganze Zeit*, 2 = *Meistens*, 3 = *Etwas mehr als die Hälfte der Zeit*, 4 = *Etwas eniger als die Hälfte der Zeit*, 5 = *Ab und zu* bis 6 = *Zu keinem Zeitpunkt* reicht. Die Reliabilität des WHO-5 wurde in verschiedenen Ländern und kulturellen Kontexten untersucht. Die Ergebnisse einer Validierungsstudie (Sischka, Costa, Steffgen & Schmidt, 2020b) zeigen eine hohe interne Konsistenz (ρ = .83-.93).

Abschließend wurden einige soziodemografischen Daten erhoben. Diese waren das Alter, das Geschlecht, der kultureller Hintergrund, die potenzielle Religionszugehörigkeit, der aktuelle Beziehungsstatus, der höchste erreichte Bildungsstand, die aktuelle Tätigkeit und in welcher Region die befragte Person wohnt (ländlich oder in der Stadt). Um den kulturellen Hintergrund zu ermitteln, wurden die Probanden gebeten, Angaben zu ihrem aktuellen Wohnort sowie etwaigem Migrationshintergrund bei sich, ihren Eltern oder ihren Großeltern zu machen, einschließlich des Landes, aus dem sie stammen, falls zutreffend. Des Weiteren wurde die Cultural Orientation Scale (Bierbrauer, Meyer & Wolfradt, 2002) genutzt. Der Fragebogen untersucht, ob eine Person aus einer individualistischen oder kollektivistischen Kultur stammt und erfragt die persönliche Meinung bezüglich sozialer Verhaltensweisen im dem Land, zu dem sich die Person zugehörig fühlt. Beide Subskalen bestehen aus jeweils 13 Items, die mithilfe einer siebenstufigen Antwortskala beantwortet werden. Der ersten Subskala bezüglich der Verbreitung gewisser Sitten und Bräuche

steht folgende Antwortoptionen bereit: 1 = *überhaupt nicht*, 2 = *Sehr selten*, 3 = *Selten*, 4 = *Manschmal*, 5 = *Häufig*, 6 = *Sehr häufig* und 7 = *Immer*. Ein Item lautet beispielsweise wie folgt: „Wie häufig richten sich Jugendliche in Deutschland bei der Wahl ihres Freundes oder ihrer Freundin nach den Ratschlägen ihrer Eltern?“. Für die englische und spanische Version wurde die Nationalität entfernt und es wurde nach dem eigenen Land gefragt, da in diesen Fällen keine spezifische Nationalität zugewiesen werden konnte. Im Anweisungstext wurde des Weiteren darauf hingewiesen, dass mit dem „eigenen Land“, jenes gemeint ist, mit dem sich die Person am meisten identifiziert. Aus einer Studie mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten ermittelten Bierbrauer et al. (2002) eine gute interne Konsistenz (Cronbachs- $\alpha = .59-.82$) für den Fragebogen. In kulturvergleichenden Studien konnte durch den Fragebogen signifikant zwischen Teilnehmern bezüglich ihrer individualistischen bzw. kollektivistischen Kulturzugehörigkeit differenzieren werden.

2.4 Untersuchungsdurchführung

Die Datenerhebung über erfolgte in dem Zeitraum vom 01.05.2022 bis 02.06.2024. Der über SoSci-Survey® erstellte Fragebogen wurde primär über Messenger-Dienste, wie WhatsApp®, Signal® oder Telegram®, aber auch über das soziale Netzwerke Instagram®, und über das Alumniportal Deutschland® verbreitet, mit der Bitte der Verbreitung, um eine möglichst große Stichprobe zu erreichen. Die Mindeststichprobengröße von 311 bis 395 wurde mithilfe des kostenlosen Tools G*Power® ermittelt.

Im Einführungstext zu Beginn der Befragung wurde auf die 10 bis 15 minütige Bearbeitungszeit und die garantierte Anonymität der Befragten hingewiesen. Die Teilnehmer wurden zudem darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig sei. Auf der anschließenden Seite begann die Befragung. Eine inhaltliche Demonstration der genutzten Fragebögen und deren Reihenfolge wurde bereits in Kapitel 2.3 dargeboten. Zu Beginn wurde die eigene Einstellung und das eigene Verhalten im Kontext zu Religiosität befragt, gefolgt von einem kurzen Fragebogen zum psychischen Wohlbefinden. Im Anschluss wurden die Probanden gebeten, einige kurze Angaben zu ihrer Person zu machen. Der inhaltliche Teil endete mit dem Fragebogen bezüglich der kulturellen Orientierung. Auf der letzten Seite wurde den Befragten für ihre Teilnahme gedankt und darauf hingewiesen, dass ihre Daten gespeichert wurden und sie nun das Browserfenster schließen können.

Potenzielle Störvariablen konnten während der Untersuchungsdurchführung nicht

kontrolliert werden. Anhand der Onlinebefragung lag die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und unter welchen Bedingungen die Befragung bearbeitet wurde, bei den Teilnehmern selbst.

2.5 Auswertungsmethode

Die Statistik- und Analysesoftware SPSS® wurde für die Berechnungen und statistischen Analysen genutzt. Bevor die Hypothesen jedoch berechnet werden konnten, musste der Datensatz bereinigt werden.

Literaturverzeichnis

- Allolio-Näcke, L. & Demmrich, S. (2022). Religion und Religiosität. In U. Wolfradt, L. Allolio-Näcke & P. S. Ruppel (Hrsg.), *Kulturpsychologie: Eine Einführung* (S. 377–386). Wiesbaden: Springer.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: W.H. Freeman und Company.
- Bierbrauer, G., Meyer, H. & Wolfradt, U. (2002). COS. Cultural Orientation Scale [Verfahrensdokumentation und Fragebogen auf Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), *Open Test Archive*. Trier: Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID).
- Borrell-Carrió, F., Suchman, A. L. & Epstein, R. M. (2004). The biopsychosocial model 25 years later: Principles, practice, and scientific inquiry. *Annals of Family Medicine*, 2(6), 576–582. doi:<https://doi.org/10.1370/afm.245>
- Bowker, J. (2003). *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*. Oxford University Press.
- Büssing, A. (2008). Spiritualität – inhaltliche Bestimmung und Messbarkeit. *Prävention*, 31(2), 35–37.
- Carver, C. S. (2010). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. *Journal of Social Issues*, 54(2), 245–266. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01217.x>
- Cohen, A. B. (2015). Religion's Profound Influences on Psychology: Morality, Intergroup Relations, Self-Construal, and Enculturation. *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), 77–82. doi:<https://doi.org/10.1177/0963721414553265>
- Croucher, S. M., Zeng, C., Rahmani, D. & Sommer, M. (2017, Januar). Religion, Culture, and Communication. doi:10.1093/acrefore/9780190228613.013.166
- Dar, K. A. & Iqbal, N. (2019). Religious Commitment and Well-Being in College Students: Examining Conditional Indirect Effects of Meaning in Life. *Journal of Religion and Health*, 58, 2288–2297. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-017-0538-2>
- Das, K. V., Jones-Harrell, C., Fan, Y., Ramaswami, A., Orlove, B. & Botchwey, N. (2020). Understanding subjective well-being: perspectives from psychology and public health. *Public Health Reviews*, 42(25). doi:<https://doi.org/10.1186/s40985-020-00142-5>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits. Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. doi:https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

- Dhanabhakyaam, M. & Sarath, M. (2023). Psychological Wellbeing: A systematic Literature Review. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, 3(1), 603–607. doi:<https://doi.org/10.48175/IJARSCT-8345>
- Diener, E., Oishi, S. & Lucas, R. E. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Positive Psychology*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhob/9780195187243.013.0017>
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R. & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin*, 125(2).
- Durkheim, E. (1915). The Elementary Forms of the Religious Life. (Kap. Definition of Religious Phenomena and of Religion, S. 47). London: George Allen & Unwin LTD.
- Durkheim, E. (1981). *Die elementare Formen des religiösen Lebens* (L. Schmidts, Übers.). Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129–136. doi:<https://doi.org/10.1126/science.847460>
- Fernández, M. B. & Rosell, J. (2022). An Analysis of the Relationship Between Religiosity and Psychological Well-Being in Chilean Older People Using Structural Equation Modeling. *Journal of Religion and Health*, 61, 1585–1604. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-021-01442-z>
- Graham, C. & Crown, S. (2014). Religion and wellbeing around the world: Social purpose, social time, or social insurance? *International Journal of Wellbeing*, 4(1), 1–27. doi:<https://doi.org/10.5502/ijw.v4i1.1>
- Griffiths, P. J. (2000). The Very Idea of Religion. *First Things*, (103), 30–35.
- Hemel, U. (2023). Der Einfluss der Religionen auf die Frauengesundheit. In J. Wacker, C. Rothe & M. En-Nosse (Hrsg.), *Globale Frauengesundheit: Gynäkologie und Geburtshilfe unter unterschiedlichen globalen Bedingungen* (S. 71–82). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-66081-2_6
- Hernandez, M. & Gibb, J. K. (2019). Culture, behavior and health. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2020(1), 12–13. doi:<https://doi.org/10.1093/emph/eoz036>
- Hewlett, B. S. & Hewlett, B. L. (2008). Ebola, Culture and Politics: The Anthropology of an Emerging Disease. In J. A. Young (Hrsg.), (Kap. Ourbreak Control, S. 111–130). CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Hoffmann, R. (1984). Erleben von Glück - eine empirische Untersuchung. *Psychologische Beiträge*, 26(3), 516–532.

- Hofstede, G. (2001). Individualism and Collectivism. In *Culture's consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2. Aufl.). Thousand Oaks: Sage.
- Hofstede, G. (2024). The 6-D model of national culture. Verfügbar unter <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/>
- Hoogeveen, S., Sarafoglou, A., Aczel, B., Aditya, Y., Alayan, A. J., Allen, P. J., ... Wagenmakers, E.-J. (2022). A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-being. *Religion, Brain & Behavior*, 13(3), 237–283. doi:<https://doi.org/10.1080/2153599X.2022.2070255>
- Hornberg, C. (2016). Gesundheit und Wohlbefinden. In U. Gebhard & T. Kistemann (Hrsg.), *Landschaft, Identität und Gesundheit: Zum Konzept der Therapeutischen Landschaften* (S. 63–69). doi:10.1007/978-3-531-19723-4_5
- Izard, C. E. (1994). Die Emotionen des Menschen: Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie (B. Murakami, Übers.). In, (3. Auflage, Kap. Freude, S. 271–312). Beltz, Psychologie-Verlags-Union.
- Jakobs, M. (2018). Religion und Gesundheit aus religionspsychologischer Perspektive - und was dies für die Religionspädagogik bedeutet. *Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik*, 17(1), 83–100. doi:<https://doi.org/10.23770/tw0048>
- Jokela, M. (2022). Religiosity, Psychological Distress, and Well-Being: Evaluating Familial Confounding With Multicohort Sibling Data. *American Journal of Epidemiology*, 191(4), 584–590. doi:<https://doi.org/10.1093/aje/kwab276>
- Joseph, R. (2011). Evolution of Paleolithic Cosmology and Spiritual Consciousness, and the Temporal and Frontal Lobes. *Journal of Cosmology*, 14, 4400.
- Karasz, A., Gany, F., Escobar, J., Flores, C., Prasad, L., Inman, A., ... Diwan, S. (2019). Mental Health and Stress Among South Asians. *Journal of Immigrant Minority Health*, 21(Suppl 1), 7–14. doi:<https://doi.org/10.1007/s10903-016-0501-4>
- Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F. & Glaser, R. (2002). Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. *Annual Review of Psychology*, 53, 83–107. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135217>
- Klumparendt, A. & Drenckhan, I. (2014). *Deutsche Version der Religious Commitment Scale*. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). doi:<https://doi.org/10.6102/zis217>

- Knecht, J. (2020). Kulturdimensionen nach Hofstede - kurz zusammengefasst. Verfügbar unter https://praxistipps.focus.de/kulturdimensionen-nach-hofstede-kurz-zusammengefasst_124852
- Koenig, H. G. (2010). Spirituality and mental health. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 7, 116–122. doi:<https://doi.org/10.1002/aps.239>
- Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *International Scholarly Research Network Psychiatry*, 1–33. doi:<https://doi.org/10.5402/2012/278730>
- Koenig, H. G. & Al Shohaib, S. (2024). Religious involvement and psychological well-being in the Middle East. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 59(3), 341–359. doi:<https://doi.org/10.1177/00912174231197548>
- Koenig, H. G. & Büssing, A. (2010). The Duke University Religion Index (DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemiological Studies. *Religion*, 1, 78–85. doi:10.3390/rel1010078
- Koenig, H. G., Parkerson, G. R. & Meador, K. G. (1997). Religion index for psychiatric research. *The American Journal of Psychiatry*, 154(6), 885–886. doi:<https://doi.org/10.1176/ajp.154.6.885b>
- Koenig, H. G., VanderWeele, T. J. & Peteet, J. R. (2024, Januar). 3C1Definitions. In *Handbook of Religion and Health*. Oxford University Press.
- Köhrsen, J. (2024). Religion und Ökologie. In M. Sonnberger, A. Bleicher & M. Groß (Hrsg.), *Handbuch Umweltsoziologie* (S. 477–489). doi:10.1007/978-3-658-37218-7_48
- Krause, C. (2015). Spirituelle und religiöse Praktiken – Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. In *Mit dem Glauben Berge versetzen? Psychologische Erkenntnisse zur Spiritualität* (S. 131–144). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-48457-9_7
- Lazar, A. & Bjorck, L. P. (2016). Religious support and psychological well-being: gender differences among religious Jewish Israelis. *Mental Health, Religion & Culture*, 19(4), 393–407. doi:<https://doi.org/10.1080/13674676.2016.1207160>
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *European Journal of Personality*, 1(3), 141–169. doi:<https://doi.org/10.1002/per.2410010304>
- Lucas, R. E. (2016). Subjective Well-Being in Psychology. In M. D. Adler & M. Fleurbaey (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.13>

- Maly-Motta, H. (2023). Gestersste Eltern. (Kap. Subjektives Wohlbefinden, S. 13–15).
doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-41224-1>
- Matsumoto, D. & Juang, L. (2016). *Culture and psychology* (6th). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Mayring, P. (1991). Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), (Kap. Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens, S. 51–71). Weinheim: Juventa.
- McGlichey, S., Waters, R. & Scheinpflug, C. (2023). International Relations. In S. McGlinchey (Hrsg.), (Kap. Religion and Culture - Difference and Similarity, S. 9.3.1). E-International Relations.
- Monroe, M. W., Spicer, R., Canlas, G. M., Chilcott, T., Christopher, S., Daniels, M., ... Slingerland, E. (2023). On the Category of Religion: A Taxonomic Analysis of a Large-Scale Database. *Journal of the American Academy of Religion*, 91(2), 257–282.
doi:[10.1093/jaarel/lfad065](https://doi.org/10.1093/jaarel/lfad065)
- Nelson, S. K., Kushlev, K. & Lyubomirsky, S. (2014). The pains and pleasures of parenting: When, why, and how is parenthood associated with more or less well-being? *Psychological Bulletin*, 140(3), 846–895.
doi:<https://doi.org/10.1037/a0035444>
- Ng, J. Y. Y., Ntoumaniy, N., Thøgersen-Ntoumani, C., Deci, E. L., Ryan, R. M., Duda, J. L. & Williams, G. C. (2012). Self-Determination Theory Applied to Health Contexts: A Meta-Analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 7(4), 325–340.
doi:<https://doi.org/10.1177/1745691612447309>
- Norenzayan, A. & Shariff, A. F. (2008). The Origin and Evolution of Religious Prosociality. *Science*, 322(5898), 58–62.
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. New York, NY: Guilford Press.
- Pearlin, L. I. (2010). The Life Course and the Stress Process: Some Conceptual Comparison. *The Journal of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65B(2), 207–215. doi:<https://doi.org/10.1093/geronb/gbp106>
- Pew Research Center. (2019). Religion’s Relationship to Happiness, Civic Engagement and Health Around the World: In the U.S. and other countries, participation in a congregation is a key factor. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2019/01/31/religions-relationship-to-happiness-civic-engagement-and-health-around-the-world/>

- Pew Research Center. (2022). Key Findings From the Global Religious Futures Project. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/>
- Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden / Well-Being. In *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden*. doi:<https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i134-1.0>
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping*. New York, NY: Henry Holt und Company.
- Schneider, G. & Toyka-Seid, C. (2024). Religion. Verfügbar unter <https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321041/religion/>
- Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G. & Schmidt, A. F. (2020a). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>
- Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G. & Schmidt, A. F. (2020b). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>
- Tay, L., Li, M., Myers, D. & Diener, E. (2014). Religion and Spirituality Across Cultures. Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology. In C. Kim-Prieto (Hrsg.), (Kap. Religiosity and subjective well-being: An international perspective, S. 163–175). doi:https://doi.org/10.1007/978-94-017-8950-9_9
- The Britannica Dictionary. (2024). religion. Verfügbar unter <https://www.britannica.com/dictionary/religion>
- Triandis, H. C. (1994). *Culture and social behavior*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Trojan, A. & Legewie, H. (2001). *Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung: Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensbedingungen*. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften.
- Uchino, B. N. (2006). Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. *Journal of Behavioral Medicine*, 29(4), 377–387. doi:<https://doi.org/10.1007/s10865-006-9056-5>
- Utler, A. (2020). Kultur, Kulturdimensionen und Kulturstandards. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (S. 1–17). doi:[10.1007/978-3-658-27825-0_3-1](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27825-0_3-1)

- Van Cappellen, P., Toth-Gauthier, M., Saroglou, V. & Fredrickson, B. L. (2016). Religion and Well-Being: The Mediating Role of Positive Emotions. *Journal of Happiness Studies*, 17, 485–505. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-014-9605-5>
- Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa. (2024). Kulturelle Kontexte von Gesundheit und Wohlbefinden. Verfügbar unter <https://who-sandbox.squiz.cloud/de/health-topics/health-determinants/behavioural-and-cultural-insights-for-health/cultural-contexts-of-health-and-well-being>
- Wielga, J. & Knospe, T. (2023). *Kulturelle und soziale Faktoren der Gesundheitskompetenz: Ein erster explorativer Ansatz* (Research Report Nr. 03/2023). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik (IAT). doi:<https://doi.org/10.53190/fa/202303%0A>
- Wilczewski, M., Wang, R., Du, R., Söderberg, A., Giuri, P., Mughan, T., ... Jacob, M. J. (2023). Cultural novelty and international students' experience: a five-country study. *Higher Education*, 86, 1107–1128.
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*. World Health Organization.
- World Health Organization. (1998). WHO (Five) Well-being Index. Verfügbar unter <https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx>